



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27
тел.: +38044 520 94 00
факс +38044 520 94 01
www.lisod.ua

Відділення променевої діагностики
Позитронно-емісійна томографія об'єднана із комп'ютерною томографією із 18F-ФДГ

Пацієнт Жерліцина Анастасія Станіславівна

ID 110889

Дата народження 25-04-1976

Дата дослідження 11-04-2023

Методика дослідження

Проведено ПЕТ/КТ сканування від рівня орбіт до середини стегон через 65 хвили після внутрішньовенного введення 10.5 мКі 18F-ФДГ. Рівень глікемії перед введенням РФП - 5.7 ммоль/л.

КТ сканування проведено із внутрішньовенним контрастування. Проведено додаткове сканування на рівні грудної клітки із затримкою дихання. Загальна DLP 1383 mGy*cm.

Корекція аттенюації ПЕТ зображень проведена на основі КТ даних. Стандартизовані показники накопичення РФП нормалізовані за вагою пацієнта (SUV).

Мета дослідження/клінічні дані

Контрольна радіологічна оцінка після проведеного лікування

Дані попередніх досліджень для порівняння/кореляції

КТ 09-02-2023

Знахідки

Голова та шия

Гіперметаболічних змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; помітна помірна асиметрія розподілу ФДГ у ділянці піднебінних мигдаликів, більше ліворуч, без окремої маси чи супутньої підозрілої лімфаденопатії, малоспецифічний, можливо і запальний розподіл.

Грудна клітка

Гіперметаболічних змін типових для метаболічно активного агресивного неопластичного ураження не знайдено; без суттєвої структурної динаміки, зокрема і дрібні легеневі вузлики.

Живіт і таз

Попередньо візуалізовані численні маси в печіці з кістозними/некротичними центральними компонентами та периферичними, переважно гіповаскулярними солідними, частинами демонструють високу активність солідних частин, до SUVmax/peak 11.1/9.8, відносно найактивніші компоненти у масі лівої частки.

Порівняно з КТ 02-2023 - невелике збільшення загальних розмірів мас, наприклад у лівій частці з 63 до 75 мм, піддіафрагмою у парвій частці з 90 до 101 мм, домінатна маса у правій частці з 18 до 19 см, також, «товщина» периферичних солідних компонентів здається більшою; окремих нових аналогічних вузлів у печінці не знайдено. Помірне розширення жовчних протоків дистальніше/довкола мас, помітніше у лівій частці, без динаміки. Великі судини печінки без помітних тромбів.

Попередньо візуалізована маса ліворуч центрована між шлунком та петлями кишки/хвостом підшлункової залози, та за своєю конфігурацією скоріш походить із стіни шлунку/підслизово розташована, демонструє активність до SUVmax 8.2, незначно збільшилася з 02-2023, з 55 до 58 мм максимальним розміром.

Окремі гіперметаболічної лімфаденопатії не знайдено, заочеревинні вузли до 8-9 мм SAD з низькою активністю.

Попередньо візуалізовані маси/вузли в матці та у/в правому яєчнику з низькою активністю (до SUVmax 2.1), без суттєвої динаміки розмірів з попередньої візуалізації, без помітних нових чи гіперметаболічних компонентів.



ЛІКАРНЯ
ІЗРАЇЛЬСЬКОЇ
ОНКОЛОГІЇ

08720, Київська обл., Обухівський район,
с. Плюти, вул. Малишка, 27
тел.: +38044 520 94 00
факс +38044 520 94 01
www.lisod.ua

В іншому, без суттєвої динаміки, інших активних/підозрілих уражень не знайдено.

Кістки та м'які тканини

Гіперметаболічних кісткових уражень не знайдено, агресивних за структурними/КТ ознаками кісткових уражень не знайдено

Радіологічний висновок

Відомі маси в печінці та маса ліворуч, що за конфігурацією скоріш походить зі стінки шлунку метаболічно активні, незначуще збільшення їх розмірів з 02-2023. Маса в матці та біля/в правого яєчника з низькою активністю/без істотного накопичення ФДГ, структурно стабільні. Нових окремих підозрілих/активних уражень з 02-2023 не знайдено. Попередніх метаболічних даних для оцінки метаболічної динаміки немає. Істотна різниця активності мас печінки/шлунку та матки дозволяє наразі припустити різні неопластичні ураження (зокрема, первинно агресивну з шлунку/GIST), чи принаймні істотну гетерогенність активності/агресивності поширеного ураження.

З повагою, Новіков М. Є.

лікар радіолог,

завідувач відділенням променевої діагностики

Лікарні Ізраїльської Онкології LISOD